MODELO ILUSTRATIVO: *gerado por inteligência artificial, com dados fictícios, para demonstrar a formatação. Apague os quadros coloridos antes da submissão.*

Tipo de publicação: Resumo simples | Publication type: Simple Abstract

AUTOMONITORAMENTO GLICÊMICO E CONTROLE METABÓLICO: PROGRAMA ESTRUTURADO EM PESSOAS COM DIABETES TIPO 2

Orientação ao autor (apague antes da submissão): *Título em Times New Roman 14, centralizado, negrito, caixa alta, sem abreviações, até 20 palavras.*

Ana Beatriz Souza[1]; Carlos Eduardo Lima[2]; Mariana Alves Ferreira[3]

[1] Graduando em Enfermagem, Universidade Exemplo, Departamento de Enfermagem, Cidade Exemplo, Minas Gerais, Brasil. ORCID: 0000-0000-0000-0000. E-mail: autor.correspondente@exemplo.com.

[2] Doutor em Ciências da Saúde, Universidade Exemplo, Departamento de Enfermagem, Cidade Exemplo, Minas Gerais, Brasil. ORCID: 0000-0000-0000-0000.

[3] Mestre em Endocrinologia, Hospital Exemplo, Setor de Endocrinologia, Cidade Exemplo, Minas Gerais, Brasil. ORCID: 0000-0000-0000-0000.

Orientação ao autor (apague antes da submissão): *Autores: Times New Roman 12, justificado, simples. Nome completo, titulação, instituição, setor, cidade, estado, país e ORCID. O primeiro autor é o correspondente (com e-mail).*

Orientação ao autor (apague antes da submissão): *Corpo do texto de 300 a 500 palavras (este tem 358), sem contar título, autores, palavras-chave e referências; Times New Roman 12, justificado, simples. Estudo original: introdução; objetivo; métodos; resultados; discussão; conclusão; referências.*

INTRODUÇÃO

O diabetes mellitus tipo 2 é uma doença crônica caracterizada por hiperglicemia persistente, com cerca de 537 milhões de adultos afetados no mundo em 2021 (1,2). O automonitoramento da glicemia capilar é recomendado, mas seu efeito isolado sobre a hemoglobina glicada em pessoas que não usam insulina é pequeno (3). Assim, é necessário avaliar programas que associem automonitoramento, educação em saúde e acompanhamento de enfermagem.

OBJETIVO

Avaliar o efeito de um programa estruturado de automonitoramento glicêmico sobre o controle metabólico e a adesão ao tratamento de pessoas com diabetes mellitus tipo 2.

MÉTODOS

Estudo quase-experimental, do tipo antes e depois, realizado em uma unidade básica de saúde, entre março e setembro de 2026. A amostra de 214 adultos foi calculada pela fórmula de Cochran (4), com confiança de 95% e erro de 5%. Incluíram-se adultos com diabetes há pelo menos um ano, sem uso de insulina. O programa consistiu em educação em saúde, orientação sobre glicemia capilar e consultas mensais de enfermagem. A hemoglobina glicada foi dosada no início e aos seis meses, e a adesão foi avaliada pelo teste de Morisky-Green (5).

Aplicaram-se teste t pareado e teste de McNemar, com significância de 5%. O estudo foi aprovado por Comitê de Ética em Pesquisa, com Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme a Resolução nº 466/2012 (6).

RESULTADOS

Participaram 214 pessoas, 58,9% do sexo feminino, com média de idade de 58,4 anos. A hemoglobina glicada média reduziu de 8,3% para 7,5% após seis meses (p<0,001). A alta adesão aumentou de 39,7% para 63,1% (p<0,001). A principal dificuldade relatada foi o custo das fitas reagentes (45,8%).

DISCUSSÃO

A redução observada é clinicamente relevante, pois metas inferiores a 7% são recomendadas para muitos adultos sem risco elevado de hipoglicemia (7), e é maior que o efeito pequeno descrito para o automonitoramento isolado (3). Isso sugere que a educação em saúde e o acompanhamento de enfermagem contribuíram para a melhora. São limitações a ausência de grupo-controle e a avaliação autorreferida da adesão.

CONCLUSÃO

O programa associou-se à redução da hemoglobina glicada e ao aumento da adesão ao tratamento, atendendo ao objetivo proposto. Recomendam-se estudos com grupo-controle e ações que garantam o acesso às fitas reagentes.

Palavras-chave: Diabetes Mellitus Tipo 2; Automonitorização da Glicemia; Hemoglobina A Glicada; Cooperação e Adesão ao Tratamento; Atenção Primária à Saúde.

> **Orientação ao autor (apague antes da submissão):** *Palavras-chave: 3 a 5 termos DeCS/MeSH, separados por ponto e vírgula (;).*

REFERÊNCIAS

> **Orientação ao autor (apague antes da submissão):** *ABNT NBR 6023:2025, numeradas na ordem de citação, alinhadas à esquerda, espaçamento simples, SOBRENOME em caixa alta.*

1. SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. **Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes 2023-2024**. São Paulo: Clannad Editora Científica, 2023.
2. INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION. **IDF Diabetes Atlas**. 10. ed. Bruxelas: International Diabetes Federation, 2021. Disponível em: https://diabetesatlas.org. Acesso em: 08 out. 2026.
3. MALANDA, Uriëll L. *et al*. Self-monitoring of blood glucose in patients with type 2 diabetes mellitus who are not using insulin. **Cochrane Database of Systematic Reviews**. Chichester, n. 1, CD005060, 2012.
4. COCHRAN, William G. **Sampling techniques**. 3. ed. Nova York: John Wiley & Sons, 1977.
5. MORISKY, Donald E.; GREEN, Lawrence W.; LEVINE, David M. Concurrent and predictive validity of a self-reported measure of medication adherence. **Medical Care**. Filadélfia, v. 24, n. 1, p. 67-74, 1986.

6. BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012**. Aprova diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Brasília, DF: CNS, 2012.
7. AMERICAN DIABETES ASSOCIATION PROFESSIONAL PRACTICE COMMITTEE. 6. Glycemic goals and hypoglycemia: standards of care in diabetes-2024. **Diabetes Care**. Alexandria, v. 47, supl. 1, p. S111-S125, 2024.